六、手术治疗

1.术前：**常规用 α-R 拮抗剂（酚苄明、哌唑嗪、多沙唑嗪）**。α-R 拮抗剂不少于 2 周、用到术前一天为止（嗜铬细胞瘤主要产生 NA：NA 对 α-R＞β_1-R＞β_2-R）

β-R 拮抗剂（XX 洛尔）在嗜铬细胞瘤的“三不”（不能用 ABCD 去思考）

①不常规用：出现心动过速、心律失常再加用 β-R 拮抗剂

②不单独用

③不会先用：否则可使血压升高、急性左心衰（肺水肿）先用β-R拮抗剂→血管收缩→血压↑↑→可能诱发急性左心衰

2.术中：若接触肿瘤等出现急骤血压升高→**酚妥拉明（首选）或硝普钠控制在 160/100**　不能直接降至正常，血压波动过大会损伤靶器官

VS 酚苄明长效，起作用慢

酚妥拉明：短效，起作用快　160/100：安全水平

3.术后若第 1 周血压仍高：

①术后应激状态

②原来体内储存儿茶酚胺较多

③儿茶酚胺长期增多损伤血管

④可能合并原发性高血压

真题解析 • 嗜铬细胞瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N174 X 嗜铬细胞瘤其心血管系统的临床表现有

A.间歇性高血压

B.持续性高血压

C.直立性低血压

D.休克

2. 2018N88-90 A 女性，32 岁。发现持续性高血压 3 年，BP 150-160/90-100mmHg，常因情绪激动或体位改变诱发血压升高，最高 210/110mmHg。伴头痛、心悸、出汗。口服多种降压药疗效不佳。查体：T 36.7℃，P 90 次/分，BP 158/95mmHg，甲状腺(-)，双肺(-)，心界不大，心律不整，可闻及期前收缩 5-6 次/分，心尖部 S_1 增强，腹部未闻及血管杂音，双下肢不肿。　交感神经四正效应

88.该患者最可能的诊断是

A.原发性高血压

B.嗜铬细胞瘤

C.肾动脉狭窄

D.原发性醛固酮增多症

89.为明确诊断，最有价值的检查是

A.超声心动图

B.肾及肾上腺 CT　定位

C.肾动脉 B 超　不是肾动脉问题，是肾上腺问题

D.腹部 X 线片　X线看不到肾上腺

90.患者因疾病而明显烦躁、焦虑，测血压 200/108mmHg，心率 108 次/分，应首选的治疗药物为

A.α 受体拮抗剂

以题带动知识点复习

答案:1-2 ABCD BBA